L.F.T. Erika jazmín Vertel Jaramillo

ERIKA VERTEL
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

HISTORIA CLINICA FISIOTERAPEUTICA

No. Expediente		Cama/ Cubículo		Fecha		Hora	

FICHA DE IDENTIFICACIÓN			
Nombre Completo		Escolaridad	
Sexo		Ocupación	
Edad		Domicilio	
F. de nacimiento		Teléfono	
Tipo de sangre		Tel. de emergencia	
Religión		Nacionalidad	
Estado civil		Lugar de radicación	
Edo. Socioeconómico		T. de interrogatorio	

MOTIVO DE CONSULTA

DIAGNÓSTICO MEDICO

TRATAMIENTOS PREVIOS

MEDICAMENTOS PREINSCRITOS

MEDIDAS FÍSICAS	
Peso	
Talla	
Estatura	
(IMC)	

SIGNOS VITALES	
Temperatura	
F. Cardíaca	
F. Respiratoria	
Tensión Arterial	

Fisio pedia

ANTECEDENTES HEREDEROFAMILIARES				
Enfermedad	*SI*	*NO*	*Parentesco*	*Especifique*
Diabetes				
E. Neurológicas				
HTA				
Neoplasias				
Cardiopatías				
E. Reumáticas				
E. respiratorias				
E. genéticas				
E. Endocrinológicas				
Otras				

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS			
Enfermedad	*SI*	*NO*	*Especifique*
Diabetes			
Alergias			
Accidentes			
Neoplasias			
Cardiopatías			
Cirugías			
E. respiratorias			
Dolor de cabeza			
Malformaciones congénitas			
E. Neurológicas			
Convulsiones/ Epilepsia			
Traumatismos			
E. Infecciosas			
E. Reumáticas			
Hospitalizaciones previas			
Otras			

ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS			
Antecedentes	*SI*	*NO*	*Especifique*
Toxicomanías			
Inmunizaciones			
Automedicación			
Trastornos del sueño: Tipo y cantidad de tiempo que duerme.			
Alimentación: Núm., cantidad, calidad, litros de agua al día.			
Habitación: Piso, ventilación, iluminación, servicios públicos, ambiente.			
Hábitos higiénicos: Baño diario, lavado de manos, higiene bucal, cambio de ropa.			
Zoonosis			
Actividad física			
Ocupación: Ambiente, higiene, jornada.			
Actividades de ocio			

EN CASO DE SER MUJER (ANTECEDENTES GINECO-OBSTERICOS)			
Antecedentes	*SI*	*NO*	*Especifique*
Menarca			
Dismenorreas			
Gesta actual			
Núm. de gestas			
Partos naturales			
Cesáreas			
Aborto			
Núm. De productos nacidos vivos			
Menopausia			

EN CASO DE SER PEDIÁTRICO (ANTECEDENTES PERINATALES)			
Antecedente	*SI*	*NO*	*Especifique*
Núm. de embarazo			
Embarazo múltiple			
Alimentación durante el embarazo: Medicamentos o vitaminas.			
Control perinatal			
Periodo de vida intrauterina: • **Inmaduro:** 21 a 28 semanas de gestación (500-1000gr). • **Prematuro:** 28 a 37 (1000 2500gr). • **Termino:** 37 a 41 (2500 o más gr). • **Postermino:** 42 en adelante.			
Parto natural o Cesárea			
Problemas durante el embarazo o parto			
Traumatismo durante el embarazo o parto			
Amerito maniobras de reanimación especiales			
Amerito estar en incubadora			
Peso y medida del niño			
Tamiz metabólico: Calificación.			
Puntaje de la escala de APGAR: • **7 Puntos o más:** Normal. • **6 o menos:** Atención a nivel hospitalario.			

EXPLORACIÓN FISICA

OBSERVACIÓN

(Inventario general y sistemático
a nivel corporal, emocional, personal y social desde el primer contacto visual con la persona que asiste)

MARCHA / DEAMBULACIÓN			
Marcha	*SI*	*NO*	*Observaciones*
Libre			
Claudicante			
Con ayuda			
Espástica			
Atáxica			
Otra			

MOVILIDAD/TRASLADOS		
Tipos	*Seleccione*	*Especifique*
Independiente		
Aparatos auxiliares		
Silla de ruedas		
Con ayuda		
Camilla		

FACIES		
Tipos	*Seleccione*	*Especifique*
Normal		
Dolorosa		
Ansiosa		
Pálida		
Cianótica		
Robicunada		
Ictericia		
Lupica		
Hipertiroidea		
Hipotiroidea		
Otra		
ACTITUD		
Tipos	*Seleccione*	*Especifique*
Neutra		
Colaboradora		
Pesimista		
Agresiva		
Otra		

NIVEL DE CONCIENCIA (ESCALA DE GLASGOW)	
Respuesta ocular	
Espontánea	4
A estímulos verbales	3
Al dolor	2
Ausencia de respuesta	1
Respuesta verbal	
Orientado	5
Desorientado /confuso	4
Incoherente	3
Sonidos incomprensibles	2
Ausencia de respuesta	1
Respuesta motora	
Obedece ordenes	6
Localiza el dolor	5
Retirada al dolor	4
Flexión anormal	3
Extensión anormal	2

Ausencia de respuesta	1
• Puntuación: 15 Normal • < 9 Gravedad • 3 Coma profundo	
Resultado:	

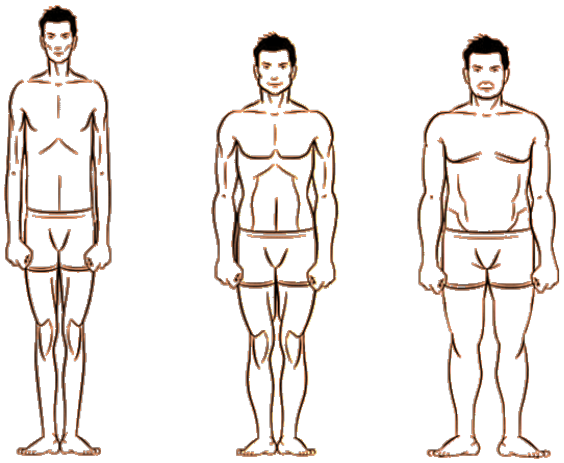
EXPLORACIÓN FISICA
INSPECCIÓN ESTÁTICA (Evaluación de la postura: Comparando con el lado contralateral)

PIEL	*SI*	*NO*	*Especifique*
Coloración normolínea			
Higiene			
LESIONES	*SI*	*NO*	*Especifique*
Cicatrices			
Excoriaciones			
Pliegues			
Edema			
Eritema			
Manchas, pecas (efélides) y lunares (nevus)			
Ampollas, máculas, pápulas, etc.			
Tumor			
Otros			

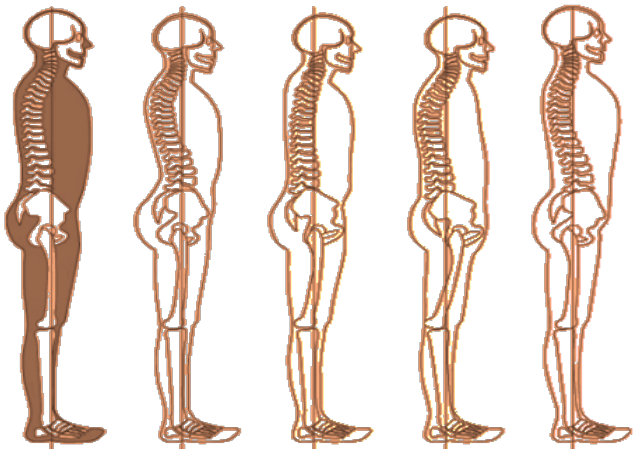
FANERAS *Pelo*	*Normolineo*	*Irregular*	*Especifique*
Cantidad			
Distribución			
Implantación			
Color			
Aspecto			
Resistencia			

Uñas	Normolineo	Irregularidad	Especifique
Forma			
Color			
Lesiones			

BIOTIPO		
Tipos	Seleccione	Especifique
Ectomorfo		
Mesomorfo		
Endomorfo		



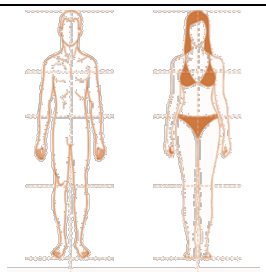
Ectomorfo Mesomorfo Endomorfo



Ideal Arqueada Aplanada Cifolordótica Militar

POSTURA		
Tipos	Seleccione	Especifique
Ideal		
Cifolordótica		
Espalda arqueada		
Militar		
Aplanada		

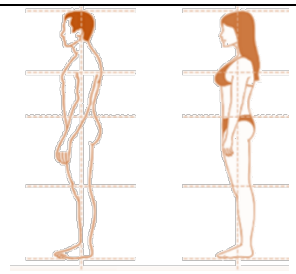
EVALUACIÓN POSTURAL
(VISTA ANTERIOR)



ALINEACCIÓN CORPORAL	Normal	Alterado	Especifique
Cráneo			
Simetría			
Tamaño			
Forma (Normocéfalo)			
Anomalías	*Si*	*No*	
Ojos			
Simetría			
Tamaño de la pupila			
Forma de la pupila			
Coloración de la esclerótica			
Movimientos simétricos			
Oídos			
Simetría			
Boca			
Simetría			
Forma			
Tamaño			
Coloración			
Movimientos			
Cabeza	*Si*	*No*	*Especifique*
Cabeza alineada con respecto al tórax			
Hombros			
Clavículas en forma horizontal y alineadas			
Hombros nivelados			
Pecho			
Pectorales alineados			
Brazos			
Alineación de manos y brazos en forma paralela			
Troco			
Tronco rotado			
Cadera			

Nivelación de las crestas iliacas			
Rotación de cadera y tronco			
Rodillas			
Orientación espacial de las rodillas			
Genu varo / valgo			
Tobillo			
Rotación interna / externa de cadera			
Pie			
Eversión / inversión			
Hallux valgus			

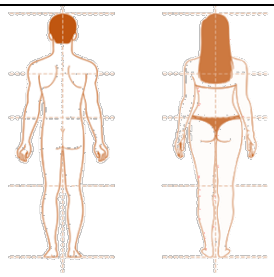
EVALUACIÓN POSTURAL
(VISTA LATERAL)



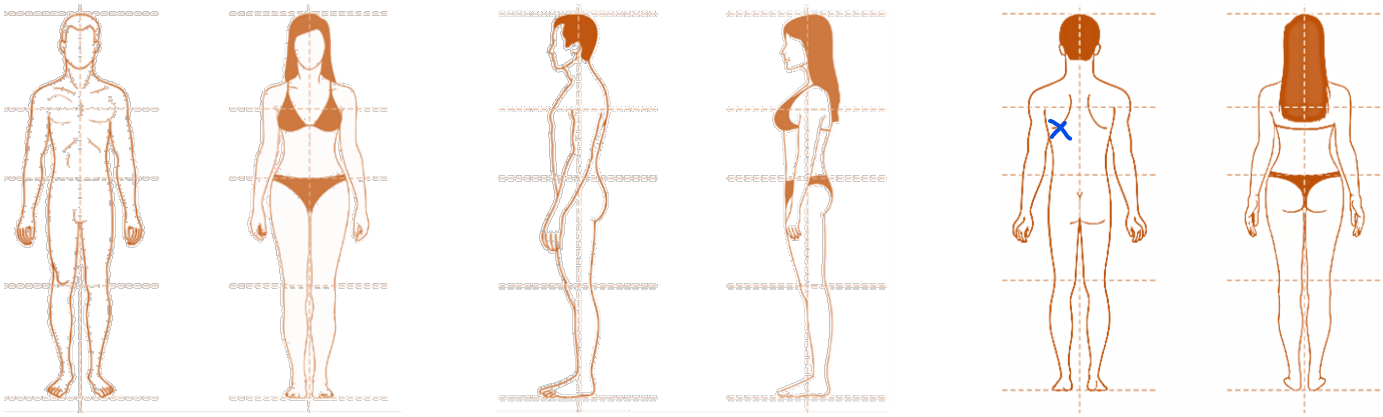
ALINEACCIÓN CORPORAL	*Normal*	*Alterado*	*Especifique*
Cabeza			
Cabeza en antepulsión			
Oídos			
Forma			
Tamaño			
Hombros	*Si*	*No*	*Especifique*
Antepulsión o retropulsión de hombros			
Pectus Excavatum / carinatum			
Pecho en tonel			
Columna			
Normal			
Cifosis			
Lordosis			
Rectificación			
Inversión			
Cadera			
Inclinación Ant. / Post. de cadera y pelvis			
Rodillas			

Genu recurvatum			
Rodillas flexionadas			

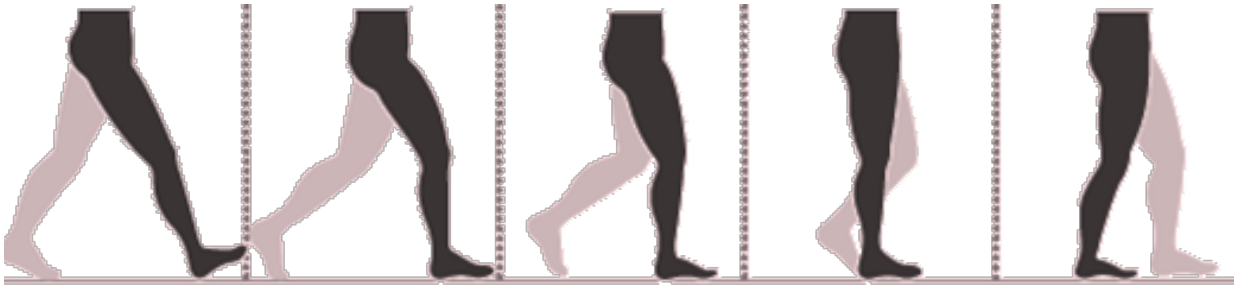
EVALUACIÓN POSTURAL
(VISTA POSTERIOR)



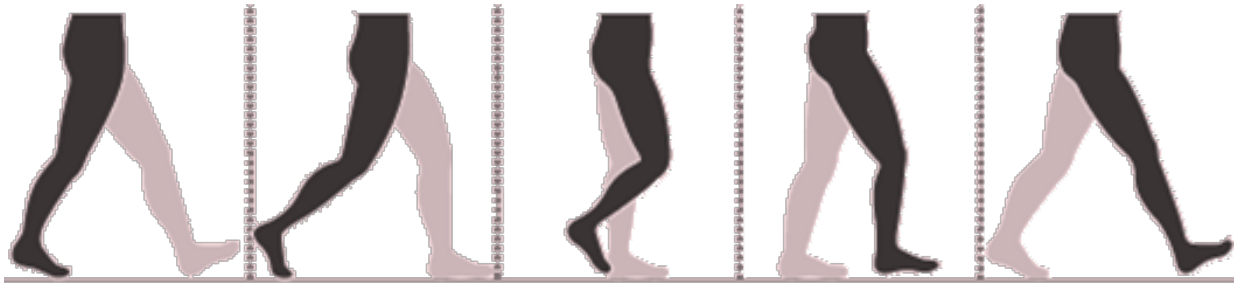
ALINEACCIÓN CORPORAL	*Normal*	*Alterado*	*Especifique*
Cabeza			
Posición de la cabeza respecto a línea de referencia			
Hombros			
Hombro caído / elevado			
Abd / Add de escapulas			
Escapulas aladas			
Columna (Estudio de las curvas fisiológicas de la columna vertebral)			
Escoliosis			
Mielomeningocele, meningocele o espina bífida			
Cadera			
Rotación Int. / Ext. de cadera			
Rodillas			
Hueco poplíteo más elevado			



INSPECCIÓN DINÁMICA
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA MARCHA



FASE DE APOYO			
Estadio	***SI***	***NO***	*Especifique*
1. Contacto inicial			
2. Respuesta a la carga			
3. Apoyo medio (fase inicial)			
4. Apoyo medio			
5. Apoyo medio (fase final)			



FASE DE BALANCEO			
Estadio	***SI***	***NO***	*Especifique*
6. Apoyo final			
7. Pre-balanceo			
8. Balanceo inicial			
9. Balanceo medio			
10. Balanceo final			

Inicio de la marcha		*Continuidad de los pasos*	
Duda o múltiples intentos para comenzar		Para o hay discontinuidad de los pasos	
No vacilante		Los pasos son continuos	
Trayectoria		*Desplazamiento del centro de gravedad*	
Balanceo marcado o utiliza ayudas			
No hay balanceo, pero si flexión de rodillas y espalda			
No hay balanceo, flexión, ni ayudas			

ADAPTACIONES DEL CUERPO DURANTE LA MARCHA	ESPECIFIQUE
Cabeza	
Hombros	
Brazos	
Columna	
Cadera y pelvis	
Rodillas	
Tobillos	
Pies	
Otros	

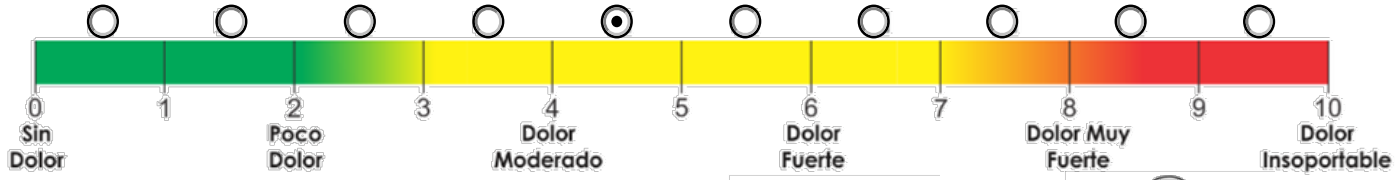
INSPECCIÓN DINÁMICA
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MARCHA

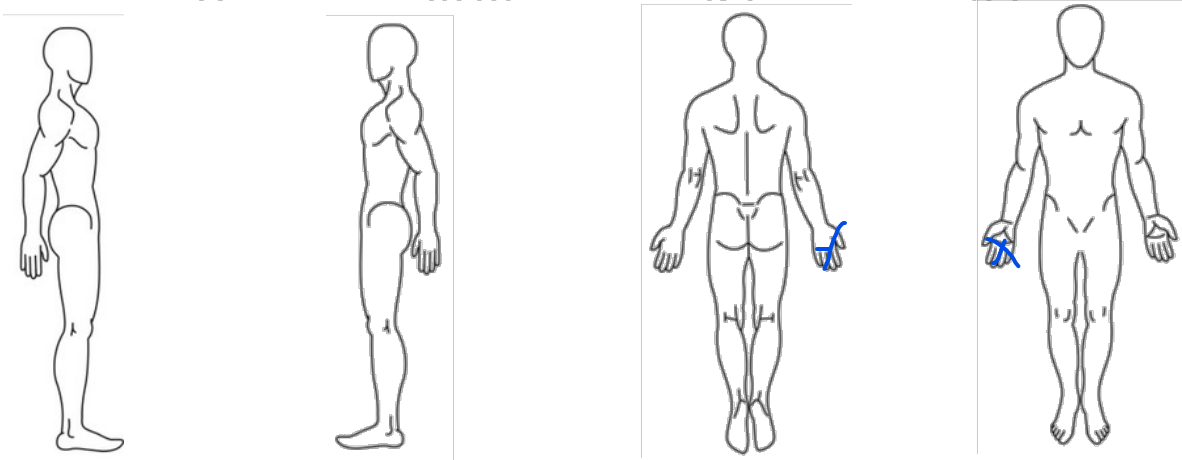
DATOS A EVALUAR	VALORES EN HOMBRES	VALORES EN MUJERES	VALORES DEL PACIENTE	
			Derecha	*Izquierda*
Longitud del paso	79 cm	66 cm		
Longitud de zancada	158 cm	132 cm		
Anchura de paso	8.1 cm	7.1		
Pasos por minuto	117 pm	117 pm		
Angulo del pie	7-10°	6°		
Velocidad	1.54 m/seg	1.31 m/seg		

EXPLORACIÓN FISICA
PALPACIÓN (Evaluación general: Comparando con el lado contralateral)

CRÁNEO	*Normal*	*Alterado*	*Especifique*
Perímetro			
Plano trasversal			
Plano Longitudinal			
Diámetro			
Borde occipital			
Apófisis mastoides			
Articulación temporomandibular			
Tuberosidad del masetero			
Otro			
CUELLO			
Cartílago tiroides			
Cartílago cricoides			
Vallecula			
Otro			
PIEL			
Dolor			
Puntos de presión			
Temperatura			
Tumoración			
Acumulación de líquidos			
Sensibilidad			
Masas			
Pulsaciones			
Otro			

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL DOLOR **(EVA)**





Vista Lateral derecha | Vista Lateral Izquierda | Vista Posterior | Vista Anterior

SEMIOLÓGICA DEL DOLOR

Datos	*Especificar*
Circunstancias	Dolor resultado de un hematoma post cirugia
Tipo	Punzon y calambres
Antigüedad	
Localización	Muñeca, mano y dedos mano derecha
Irradiación	Hacia el codo, antebrazo y brazo.
Aumento	En las noches
Atenuación	
Duración	
Actividades que le cuestan realizar	cualquier tipo de agarre

EXPLORACIÓN FISICA
INSPECCIÓN Y PALPACIÓN (Evaluación por aparatos y sistemas: Comparando con el lado contralateral)

SISTEMA ÓSEO			
Inspección	*Si*	*No*	*Especificaciones*
Simetría ósea			
Deformidades			
Tumefacción			
Edema en partes blandas			
Palpación	*Si*	*No*	*Especificaciones*
Dolor			
Aumento/difuso localizado			
Disminución del volumen			
Depresiones óseas			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO SUPERIOR)						
IZQUIERDA			RAQUIS CERVICAL	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-35/45°)			
			Extensión (0-35/45°)			
			Inclinación lateral derecha (0-45°)			
			Inclinación lateral izquierda (0-45°)			
			Rotación izquierda (0-60/80°)			
			Rotación derecha (0-60/80°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO SUPERIOR)						
IZQUIERDA			RAQUIS DORSOLUMBAR	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-80°)			
			Extensión (0-30°)			
			Inclinación lateral izquierda (0-30/35°)			
			Inclinación lateral derecha (0-30/35°)			
			Rotación izquierda (0-30/45°)			
			Rotación derecha (0-30/45°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO SUPERIOR)						
IZQUIERDA			HOMBRO	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-150/170°)			
			Extensión (0-40/60°)			
			Abducción (0-160/180°)			
			Aducción (0-30°)			
			Rotación interna (0-70°)			
			Rotación externa (0-70/90°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO SUPERIOR)						
IZQUIERDA			CODO	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-150°)			
			Extensión (0°)			
			Pronación (0-80/90°)			
			Supinación (0-60/80°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO SUPERIOR)						
IZQUIERDA			MUÑECA	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-50/80°)			
			Extensión (0-35/70°)			
			Desviación radial (0-20/30°)			
			Desviación cubital (0-60/40°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO INFERIOR)						
IZQUIERDA			CADERA	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-120/140°)			
			Extensión (0-10/30°)			
			Abducción (0-45/50°)			
			Aducción (0-30°)			
			Rotación interna (0-40/45°)			
			Rotación externa (0-45/50°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO INFERIOR)						
IZQUIERDA			RODILLA	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión (0-135/150°)			
			Extensión (0 /10° Pasiva)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO INFERIOR)						
IZQUIERDA			TOBILLO	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Flexión plantar (0-50°)			
			Flexión dorsal (0-20/30°)			

VALORACIÓN RANGOS DE MOVIMIENTO (MIEMBRO INFERIOR)						
IZQUIERDA			ART. SUBASTRAGALINA	DERECHA		
Fecha	Fecha	Fecha		Fecha	Fecha	Fecha
			RANGOS NORMALES			
			Inversión (0-50°)			
			Eversión (0-20/30°)			

Observaciones

SISTEMA MUSCULAR			
Inspección	*Si*	*No*	*Especificaciones*
Volumen			
Atrofia o hipertrofia			
Tumoraciones			
Tono muscular			
Movilidad activa			
Palpación	*Si*	*No*	*Especificaciones*
Dolor			
Consistencia			
Espasmos			
Movilidad pasiva			

FUERZA MUSCULAR (ESCALA DE DANIELS)	
Grado 5	Fuerza muscular normal contra resistencia completa.
Grado 4	La fuerza muscular está reducida pero la contracción muscular puede realizar un movimiento articular contra resistencia.
Grado 3	La fuerza muscular está reducida tanto que el movimiento articular solo puede realizarse contra gravedad, sin la resistencia del examinador.
Grado 2	Movimiento activo que no puede vencer la fuerza de gravedad
Grado 1	Esbozo de contracción muscular.
Grado 0	Ausencia de contracción muscular.

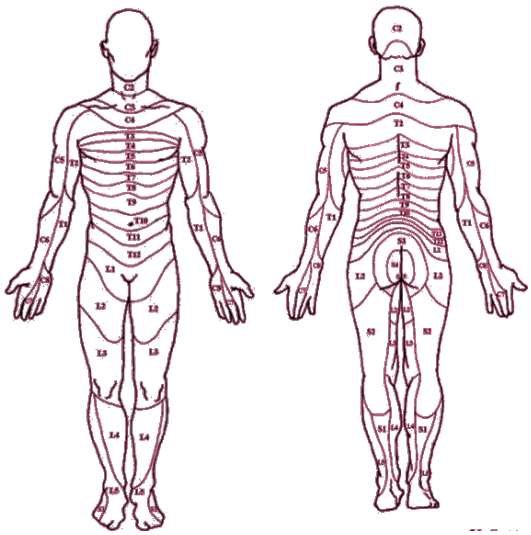
EVALUCIÓN MUSCULAR (ESCALA DE DANIELS)					
MÚSCULO	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
	Grado	*Grado*	*Grado*	*Grado*	*Grado*
Observaciones:					

EVALUACIÓN MUSCULAR (ESCALA DE DANIELS)		
Izquierda	**CUELLO**	*Derecha*
	Extensión de la cabeza	
	Extensión cervical	
	Extensión combinada (de la cabeza y cervical)	
	Flexión de la cabeza	
	Flexión cervical	
	Flexión combinada (de la cabeza y cervical)	
	Flexión y rotación combinada (esternocleidomastoideo)	
	Rotación cervical	
	TRONCO	
	Extensión lumbar	
	Extensión torácica	
	Elevación pélvica	
	Flexión	
	Rotación	
	Fuerza del diafragma	
	Inspiración máxima menos espiración completa (prueba intercostal indirecta)	
	Tos (espiración forzada indirecta)	
	HOMBRO	
	Abducción y rotación superior escapulares	
	Elevación escapular	
	Aducción escapular	
	Aducción y rotación inferior escapulares	
	Flexión de hombro	
	Extensión de hombro	
	Elevación parcial de hombro	
	Abducción de hombro	
	Abducción horizontal de hombro	
	Aducción horizontal de hombro	
	Rotación externa de hombro	
	Rotación interna de hombro	

	CODO	
	Flexión	
	Extensión	
	Pronación	
	Supinación	
	MUÑECA	
	Flexión	
	Extensión	
	Desviación radial	
	Desviación cubital	
	DEDOS DE LA MANO	
	Flexión metacarpofalángica de dedo	
	Flexión interfalángica proximal de dedo	
	Flexión interfalángica distal de dedo	
	Extensión metacarpofalángica de dedo	
	Abducción de dedo	
	Aducción de dedo	
	Flexión metacarpofalángica de pulgar	
	Flexión interfalángica de pulgar	
	Extensión metacarpofalángica de pulgar	
	Extensión interfalángica de pulgar	
	Abducción carpometacarpiana del pulgar	
	Aducción carpometacarpiana del pulgar	
	Aducción de pulgar	
	Oposición de pulgar	
	Oposición de meñique	
	CADERA	
	Flexión	
	Flexión, abducción y rotación externa de cadera con flexión de rodilla (sartorio)	
	Extensión de cadera	
	Extensión de cadera (glúteo mayor)	
	Abducción de cadera	

	Abducción y flexión de cadera	
	Aducción de cadera	
	Rotación externa de cadera	
	Rotación interna de cadera	
	RODILLA	
	Flexión de rodilla	
	Flexión de rodilla con rotación externa de la pierna	
	Flexión de rodilla con rotación interna de la pierna	
	Extensión de la rodilla	
	TOBILLO	
	Flexión plantar de tobillo	
	Flexión plantar de tobillo (sóleo)	
	Flexión dorsal e inversión de pie	
	Inversión de pie	
	Eversión con flexión plantar	
	Eversión con flexión dorsal	
	DEDOS DE LOS PIES	
	Flexión metatarsofalángica de dedo gordo	
	Flexión metatarsofalángica de los dedos	
	Flexión interfalángica de dedo gordo	
	Flexión interfalángica de los dedos	
	Extensión metatarsofalángica de dedo gordo	
	Extensión metatarsofalángica de los dedos	
	Extensión interfalángica de dedo gordo	
	Extensión interfalángica de los dedos	

VALORACIÓN NEUROLÓGICA (SENSIBILIDAD SUPERFICIAL)				
Dermatomas	*Táctil*	*Térmica*	*Dolorosa*	*Especificaciones*
C2				
C3				
C4				
C5				
C6				
C7				
C8				
T1				
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
T10				
T11				
T12				
L1				
L2				
L3				
L4				
L5				
S1				
S2				
S3				
S4				
S5				



ESCALA DE ASHWORTH MODIFICADA (HIPERTONÍA)	
Grado	*Descripción*
0	Sin aumento en el tono muscular.
1	Aumento discreto del tono con resistencia mínima al movimiento pasivo.
+ 1	Aumento discreto del tono con resistencia en todo el movimiento pasivo.
2	Disminución del rango de movimiento mayor de 50% y menor del 100%
3	Rango de movilidad limitada en menos del 50%.
4	Limitación severa a la movilidad.
Resultado:	

ESCALA DE CAMPBELL (HIPOTONÍA)	
Grado	*Descripción*
Hipotonía severa (-3)	ACTIVO: Inhabilidad para resistir la gravedad. Falta de contracción de las articulaciones proximales para la estabilidad y aparente debilidad.
	PASIVO: Ninguna resistencia al movimiento impuesto por el examinador, completo o excesivo rango de movimiento, híperlaxitud.
Hipotonía moderada (-2)	ACTIVO: El tono muscular está disminuido principalmente en la músculos axiales y proximales, interfiere con la cantidad de tiempo que mantiene una postura
	PASIVO: Muy poca resistencia al movimiento impuesto por el examinador. Se encuentra menos resistencia en el movimiento alrededor de las articulaciones proximales, híperlaxitud de rodillas y tobillos en las tomas de peso.
Hipotonía leve (-3)	ACTIVO: Interfiere con las contracciones de la musculatura axial. Retraso en el inicio del movimiento contra gravedad. Reducida velocidad de ajuste en los cambios posturales.
	PASIVO: Arco de resistencia a los cambios articulares. Completo rango de movimiento pasivo. Híperlaxitud limitada a manos, tobillos y pies.
Normal (0)	ACTIVO: Rápido e inmediato ajuste postural durante el movimiento. Habilidad para usar lis músculos en patrones sinérgicos recíprocos para la estabilidad y la movilidad dependiendo de la tarca.
	PASIVO: Las partes del cuerpo se resisten al movimiento. Momentáneamente se mantiene una nueva postura cuando es colocado en el espacio. Puede seguir rápidamente movimientos impuestos por el examinador.
Resultado:	

VALORACIÓN DE REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS						
Reflejo	*Sin respuesta (0)*	*Hiporreflexia (1)*	*Normal (2)*	*Hiperreflexia (3)*	*Clonus (4)*	*Observaciones*
Maseterino						
Bicipital						
Tricipital						
Estilorradial						
Cutáneo abdominal						
Rotuliano						
Aquiliano						
Plantar						

PARES CRANEALES	
Par craneal	*Especificaciones*
I. Olfatorio	
II. Óptico	
III. Óculo motor	
IV. Patético	
V. Trigémino	
VI. Abducens	
VII. Facial	
VIII. Acústico-vestibular	
IX. Glosofaríngeo	
X. Neumogástrico	
XI. Espinal	
XII. Hipogloso	

MANIOBRAS, ESCALAS O TEST EXPLORATORIOS		
Nombre	*Resultado y observaciones*	*¿Qué evalúa?*

PRUEBAS DE IMAGEN O EXÁMENES COMPLEMENTARIOS		
Tipo de examen	*Proyección*	*Resultado*

PLAN ANALÍTICO DE ATENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA	
Padecimiento actual	
Diagnóstico (funcional) fisioterapéutico	
Pronóstico de la enfermedad	
Objetivos del tratamiento	
Objetivos generales	Objetivos específicos

Plan de atención y tratamiento		
Total de sesiones	Sesiones semanales	Duración de cada sesión

Observaciones